뇌동맥류 의심 소견, 진단과 위험도부터 확인합니다

검진에서 발견되는 병변은 작은 경우가 많습니다. 신경외과에서 영상과 개인 요인을 함께 평가합니다.

주머니 돌출과 깔때기 확장은 다릅니다



뇌동맥류는 혈관벽이 주머니처럼 돌출된 병변입니다. 깔때기 확장은 정점에서 정상 미세혈관이 갈라지는 형태로 감별합니다.

진단명에 따라 의미가 달라집니다

소견	강의에서 설명한 의미
뇌동맥류	혈관벽 일부가 주머니처럼 부풀어 오른 병변. 크기·위치·모양·증상에 따라 관찰 또는 치료를 정합니다.
깔때기 확장 (infundibulum)	주로 혈관 기시부의 **≤3mm** 원뿔·깔때기 모양. 정점에서 분지 혈관이 나옵니다. 치료가 필요 없는 변이로, 추적 관찰을 설명했습니다.
해면정맥동 분절 등	해면정맥동(cavernous) 병변과 작은 paraclinoid 병변은 대개 위험이 낮다고 설명했습니다. 위치를 정확히 구분합니다.

작다고 바로 치료하거나 방치하지 않습니다

신경외과에서 위험도 평가를 먼저

일반 성인의 약 **2~5%**에서 발견되고, 검진 병변의 대다수는 **<5mm**입니다. **박중철 연자 Q&A:** 작은 병변도 크기만으로 판단하지 말고 먼저 신경외과에서 위험도를 확인한 뒤 저위험이면 정기 추적을 이어가도록 답했습니다.

박중철 연자 Q&A: 3mm 우연 발견 사례에는 무게 드는 운동을 포함해 제한하는 운동이 없다고 답했습니다.

광교바른내과 의원
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · 031-893-4560
평일(월–금) 08:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
토요일 08:30 – 13:30 · 일요일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

본 자료는 일반 안내입니다. 약의 시작·용량·중단은 위험도와 검사 결과를 보고 진료실에서 정하며, 약은 임의로 끊지 마시고 상의해 주세요.

관찰과 치료는 크기·위치·모양·증상으로 정합니다

연구의 평균 위험은 내 위험과 같지 않습니다. 나이와 치료 합병증까지 함께 비교합니다.

같은 크기라도 평가가 달라집니다

평가 요소	관찰·치료 결정에 미치는 점
크기 · 위치	강의에서 미국 기준은 전방 **≥7mm**, 후방 **≥6mm** 치료 고려, 국내는 **5~7mm** 또는 후방순환을 적극 고려한다고 설명했습니다.
모양 · 변화	불규칙한 돌출(daughter sac·bleb), 새 돌출, 크기 증가를 봅니다.
증상	뇌신경 마비나 극심한 국소 두통이 있으면 크기와 무관하게 신속한 치료 평가를 합니다.
나이 · 병력	나이·고혈압·지주막하출혈 이력·가족력 등과 시술·수술 위험을 함께 비교합니다.

강의에 소개된 일본 UCAS 연구의 연간 파열률

크기 · 1년 동안의 파열률

3~4mm	5~6mm	7~9mm	10~24mm	≥25mm
0.36%	0.50%	1.69%	4.37%	33.4%

6,697개 비파열 동맥류를 11,660 동맥류·년 추적한 연구로, 전체 연간 파열률은 0.95%였습니다. 개인의 크기·위치·모양을 함께 해석합니다.

파열 위험과 치료 위험을 함께 저울질합니다

나에게 이득이 큰 선택을 찾습니다

강의에서는 **<5mm** 소형 병변의 연간 파열률을 **0.1~0.5%**로, 저위험 뇌동맥류 치료의 영구 신경학적 합병증을 **1~2%**로 소개했습니다. 전교통·후교통동맥은 다른 전방 위치보다 더 주의하며, 불규칙한 모양과 증상이 있으면 작은 병변도 평가가 달라집니다.

광교바른내과 의원
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · 031-893-4560
평일(월–금) 08:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
토요일 08:30 – 13:30 · 일요일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

본 자료는 일반 안내입니다. 약의 시작·용량·중단은 위험도와 검사 결과를 보고 진료실에서 정하며, 약은 임의로 끊지 마시고 상의해 주세요.

정기 영상과 혈압·금연, 내가 이어갈 관리입니다

관찰을 택했다면 크기와 모양의 변화를 놓치지 않도록 다음 검사일을 기록합니다.

치료하지 않은 동맥류의 추적 일정

1. **발견 후 6~12개월** · 첫 추적 MRA로 크기·모양 변화를 봅니다.
2. **안정적이면 1~2년 간격** · 장기 추적으로 이어가며 간격은 개인별로 정합니다.
3. **변화·증상이 생기면** · 1~2mm 이상 증가나 새 돌출·불규칙성이 생기면 신경외과에서 즉시 치료를 재평가합니다.

위험인자를 줄이고 가족력도 알립니다

관리·정보	강의에서 제시한 내용
혈압 · 담배	목표 혈압 **<130/80mmHg**를 제시했습니다. 흡연은 형성·파열 위험을 **2~3배** 높일 수 있어 금연과 혈압 관리가 중요합니다.
음주 · 약물	과음과 교감신경 자극제(코카인 등)를 피하도록 설명했습니다.
1촌 가족력	1촌 **2명 이상** 뇌동맥류·지주막하출혈이면 **20세 이상**부터 선별 MRA를 권고했습니다. 1명은 약 **3배**, 2명 이상은 유병률 **≥10%**로 소개됐습니다.
상염색체 우성 다낭신(ADPKD)	유병률 약 **8~12%(일반인의 4~5배)**. 초기 MRA와 정상이어도 **4~5년** 간격 재검을 설명했습니다. 결합조직질환 가족·병력도 알립니다.

박중철 연자 Q&A: 다른 질환으로 항혈소판제·항응고제가 필요한 경우 동맥류만으로 금기하지 않되, 파열 때 출혈이 많을 수 있다고 답했습니다.

갑작스런 눈꺼풀 처짐·겹쳐 보임

새로 생기면 지체 없이 평가받습니다

한쪽 눈꺼풀이 갑자기 처지고 물체가 겹쳐 보이는 복시는 동맥류가 눈을 움직이는 신경을 누르는 신호일 수 있습니다. 특히 **동공이 커지는 증상**을 동반하면 **곧바로 응급실 평가**가 필요하다고 강조했습니다. 동공이 괜찮아 보인다는 이유로 스스로 판단하지 마세요.

광교바른내과 의원
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · 031-893-4560
평일(월–금) 08:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
토요일 08:30 – 13:30 · 일요일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

본 자료는 일반 안내입니다. 약의 시작·용량·중단은 위험도와 검사 결과를 보고 진료실에서 정하며, 약은 임의로 끊지 마시고 상의해 주세요.

치료를 받았거나 내시경·수술을 앞두었다면 알려주세요

치료한 뒤에도 재발·다른 부위의 새로운 동맥류를 살피는 추적과 혈압·금연 관리가 이어집니다.

치료법과 치료 뒤의 추적

치료	강의에서 설명한 특징·영상 일정
클리핑	머리를 여는 수술로 동맥류 목을 집어 막습니다. 완전 폐색·내구성이 장점이며, **5년 내** MRA 또는 CTA 추적을 제시했습니다.
코일색전술	혈관 안으로 코일을 넣는 비교적 덜 침습적인 치료입니다. 회복이 빠르지만 재개통을 살피며 **6개월·18개월·3~5년** 혈관조영술 또는 MRA를 제시했습니다.
스텐트 보조 시술	혈전 예방을 위해 아스피린+클로피도그렐 이중 항혈소판요법을 보통 **3~6개월** 사용합니다. 이 기간의 출혈 위험도 함께 봅니다.

내시경·수술·임신은 협진으로 계획합니다

상황	진료 때 알려줄 것
내시경	소형·저위험 병변은 그 자체로 금기가 아닙니다. 대형·증상성은 미리 신경외과 협진. 치료 날짜·종류·항혈전제 복용을 알리고 혈압 변동을 관리합니다.
용종 절제 등 고위험 내시경	점막절제술(EMR)·점막하박리술(ESD)은 출혈·혈전 위험을 비교해 신경외과·소화기내과에서 약과 시점을 정합니다.
전신마취 수술	강의의 627명 분석에서 파열 **0.16%**. 마취 유도·회복 중 혈압 변동을 관리하며 수술 전 예방적 동맥류 치료를 일률적으로 권하지 않았습니다.
임신	혈액량·심박출량 변화가 있어 크기·위치별 평가와 신경외과·산부인과 협진을 설명했습니다.

운동·약에 관한 박중철 연자 Q&A

스텐트 보조 시술 후에는 이중 항혈소판제 **3~6개월(아산 3개월)**, 이후 아스피린 단독 **1~1.5년**을 설명했습니다.

광교바른내과 의원
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · 031-893-4560
평일(월–금) 08:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
토요일 08:30 – 13:30 · 일요일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

본 자료는 일반 안내입니다. 약의 시작·용량·중단은 위험도와 검사 결과를 보고 진료실에서 정하며, 약은 임의로 끊지 마시고 상의해 주세요.

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/neurology/brain-aneurysm-followup-asan28/